PFE - Pleito de Financiamento Externo
Reorganização e Expansão a garantir o Direito à Saúde em João Pessoa - REDS+JP

Proponente: Município de João Pessoa
Processo SEI: 03101.000071/2026-18
Código do pleito: 2333990427/2026
Versão: 3

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 99.200.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 24.800.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 07
1. 3. Objetivo 09
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 11
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 12
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 12
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 13
1. 5. Componentes 13
1. 5. 1. Informações do 1° componente 13
1. 5. 2. Informações do 2° componente 22
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 6. Beneficiários 27
1. 7. Anexos 28
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 29
2. 1. Áreas estratégicas 29
2. 2. Anexos 31
3. GESTÃO 33
3. 1. Arranjo institucional 33
3. 1. 1. Descrição 33
3. 1. 2. Orgãos Executores 34
3. 1. 3. Estrutura Operacional 34
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 37
3. 2. Operacionalização e Manutenção 37
3. 3. Planejamento Estratégico 38
3. 4. Anexos 39
4. RISCOS 40
4. 1. Informações do 1° risco 40
4. 2. Informações do 2° risco 40
4. 3. Informações do 3° risco 40
4. 4. Informações do 4° risco 40
4. 5. Informações do 5° risco 41
4. 6. Informações do 6° risco 41
4. 7. Informações do 7° risco 41
4. 8. Anexos 41
5. FINANCIAMENTO 42
5. 1. Condições Financeiras da Operação 42
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 42
5. 2. Cronograma de Desembolso 43
5. 3. Contragarantias 44

5. 4. Anexos 44
6. ETAPAS REALIZADAS 45
6. 1. Etapas realizadas 45
6. 2. Anexos 45
7. CONTATOS 46
7. 1. Contatos 46
7. 2. Anexos 46
8. Baixar todos os anexos 47

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Reorganização e Expansão a garantir o Direito à Saúde em João Pessoa - REDS+JP
Sigla: REDS+JP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de João Pessoa

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, é o principal polo urbano, econômico, político-administrativo e assistencial da 1ª Macrorregião de Saúde, desempenhando papel estratégico na oferta de serviços de média e alta complexidade para a população local e para municípios vizinhos. Com mais de 830 mil habitantes e posição central na organização do sistema de saúde estadual, a cidade concentra hospitais próprios, filantrópicos e contratualizados, além de serviços de referência em diversas especialidades. Essa centralidade, entretanto, traz crescente demanda por serviços, pressionando a capacidade da rede municipal.

Do ponto de vista sociodemográfico, João Pessoa atravessa um processo de transição populacional acelerada. O índice de envelhecimento saltou de 31,6 em 2010 para 52,2 em 2022, o que representa 52 idosos para cada 100 crianças e adolescentes. Essa mudança demográfica amplia a prevalência de doenças crônicas, aumenta a necessidade de cuidados prolongados, reabilitação, atenção geriátrica e serviços especializados, impactando a estrutura e os custos do sistema de saúde. Ao mesmo tempo, persistem desigualdades territoriais e socioeconômicas, com bolsões de vulnerabilidade que interferem na equidade do acesso e nos resultados em saúde.

No campo epidemiológico, os dados evidenciam desafios relevantes. Em 2025, João Pessoa registrou 15 óbitos maternos, representando mais da metade das mortes do estado. A mortalidade infantil, embora tenha apresentado tendência de redução ao longo da última década, mostra instabilidade no componente pós-neonatal, com aumento expressivo em 2022, sugerindo fragilidades no acompanhamento após a alta hospitalar. Quanto ao perfil de internações (2018–2025), observa-se predominância da faixa etária de 15 a 49 anos (49%) e pessoas com mais de 50 anos (37%), confirmando alta demanda de adultos em idade produtiva e idosos nos serviços hospitalares.

A análise da produção hospitalar entre 2018 e 2025 demonstra queda no valor médio mensal, aumento do tempo médio de permanência (6,2 dias, acima das médias estadual e nacional) e elevação da taxa de mortalidade (4,81%, superior à média do Nordeste). Além disso, 54,2% das internações em 2024 foram de urgência, contrariando as diretrizes do SUS, que preveem a atenção primária e especializada organizada como principal porta de entrada, de forma eletiva. Esse dado sinaliza baixa resolutividade pré-hospitalar, insuficiência de retaguarda e dificuldades na regulação de leitos.

No aspecto assistencial, destacam-se gargalos nas áreas de oncologia, cardiologia, saúde materno-infantil, ortopedia, e diagnóstico por imagem. A demanda reprimida, o tempo de espera elevado, a escassez de leitos em áreas críticas e a fragmentação entre os níveis de atenção indicam limitações na capacidade instalada e nos fluxos assistenciais.

No eixo da infraestrutura, diversas unidades hospitalares próprias (ex.: Hospital Municipal Santa Isabel, Complexo Hospitalar de Mangabeira, Hospital Municipal Valentina) apresentam estruturas físicas e equipamentos desatualizados. Além da unidade estratégica, hoje, toda custeada pelo município, como o antigo Hospital Prontovida (atual Hospital Geral e do Câncer).

No contexto estadual, a proposta fundamenta-se na existência de vazios assistenciais e concentração de serviços especializados na capital, evidenciada pela elevada demanda regulada proveniente de municípios da macrorregião, indicando desigualdade no acesso à média e alta complexidade. João Pessoa concentra parte expressiva das internações de média e alta complexidade, assumindo papel de referência regional. Essa sobrecarga decorre da insuficiência de retaguarda em municípios vizinhos e da concentração de serviços na capital. Assim, a pressão sobre a rede municipal não é apenas local, mas também regional, exigindo maior capacidade instalada, integração entre níveis de atenção e fortalecimento da governança. A rede municipal de saúde exerce papel estratégico no atendimento de demandas provenientes de outros municípios, especialmente nos serviços de média e alta complexidade, caracterizando-se como referência regional consolidada.

Nesse contexto, o REDS+JP contempla:

- Organização dos fluxos assistenciais intermunicipais, com base em regulação compartilhada;
- Ampliação da capacidade instalada em serviços estratégicos de referência regional, com destaque para a atenção oncológica e hospitalar;
- Integração com a rede estadual e demais municípios por meio de instrumentos de pactuação interfederativa (CIR e CIB);
- Estruturação da regulação assistencial com foco na transparência, equidade e acesso regional.

Do ponto de vista organizacional, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passou por atualização de seu organograma em 2025, após quase duas décadas sem revisões estruturais. Esse movimento indica reconhecimento

institucional das mudanças no perfil assistencial e das exigências legais e de governança. Apesar disso, a infraestrutura física da sede é inadequada às novas demandas, e setores estratégicos, como o Complexo Regulador e a Vigilância Sanitária, funcionam de forma fragmentada, em espaços alugados ou improvisados, sem condições logísticas e tecnológicas adequadas.

Em síntese, João Pessoa se insere em um contexto de crescente demanda por serviços de saúde, marcado por transição demográfica acelerada, pressões assistenciais complexas, infraestrutura hospitalar desigual, desafios na gestão de fluxos e necessidade de modernização institucional. Essa combinação de fatores impacta diretamente a eficiência, a qualidade e a sustentabilidade do sistema municipal de saúde, configurando uma realidade que requer análise aprofundada dos problemas, de suas causas e consequências, juntamente com a adoção de estratégias inovadoras de financiamento e gestão. Nesse cenário, o financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apresenta-se como instrumento essencial para viabilizar um salto qualitativo e estrutural na rede municipal de saúde, permitindo assim, alavancar investimentos estratégicos de médio e longo prazo, com impacto direto na eficiência operacional, na qualidade assistencial e na sustentabilidade fiscal do sistema de saúde de João Pessoa.

1. 2. 6. **Problema:**

A rede municipal de saúde de João Pessoa apresenta um conjunto de problemas estruturais, assistenciais e institucionais que comprometem a capacidade do sistema em assegurar acesso oportuno, qualidade do cuidado, resolutividade e sustentabilidade. Esses problemas são interdependentes, acumulados historicamente e agravados pelas mudanças demográficas e epidemiológicas, resultando em impactos diretos na população e na eficiência da gestão.

1. Problemas assistenciais

- Filas e demora no acesso a consultas especializadas, cirurgias e exames de diagnóstico por imagem.
- Demanda reprimida em áreas críticas como oncologia, cardiologia, ortopedia e saúde mental.
- Predominância de internações de urgência (54,2%), indicando falhas no acesso eletivo e na organização pré-hospitalar.
- Taxa de mortalidade hospitalar elevada (4,81%), acima das médias regional e nacional.
- Tempo médio de permanência prolongado (6,2 dias), refletindo baixa resolutividade e dificuldades na transição do cuidado.
- Fragmentação dos fluxos assistenciais, com falhas na referência e contrarreferência entre APS, urgência, especializada e hospitais.
- Sobrecarga de UPAs e serviços de urgência, utilizada como porta de entrada principal devido à falta de alternativas estruturadas.

2. Problemas de infraestrutura física e capacidade instalada

- Hospitais próprios desatualizados, com limitações de espaço, layout inadequado conforme legislação para seguir com habilitações.
- Hospital Geral e do Câncer, prédio locado, com assistência toda custeada pelo município, que enfrenta impedimentos jurídicos para habilitação no SUS, em que não se pode adequar, estando o prédio para leilão, tendo que encerrar o funcionamento do mesmo.

- Insuficiência de leitos em áreas de alta demanda, especialmente em oncologia, cardiologia e materno-infantil.
- Estrutura física da Base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) inadequada, com limitações de espaço, ausência de áreas padronizadas para higienização e manutenção de ambulâncias, condições precárias para o repouso das equipes e carência de infraestrutura tecnológica e logística. Essa situação compromete a segurança operacional, o tempo-resposta às ocorrências e o conforto dos profissionais, além de afetar a articulação com as demais unidades da Rede de Atenção às Urgências.
- Ausência de serviços essenciais na rede própria, como Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), Centro de Hemodiálise e unidades especializadas para autismo e idosos.
- Dependência de prestadores filantrópicos e privados, tanto para leitos quanto para procedimentos de média e alta complexidade.

3. Problemas de gestão, regulação e organização da rede

- Complexo Regulador fragmentado, distribuído em prédios alugados ou improvisados, sem estrutura para funcionamento contínuo e integrado.
- Baixa articulação entre níveis de atenção, reforçando a fragmentação assistencial e a sobrecarga hospitalar.

4. Problemas institucionais e organizacionais

- Estrutura física da SMS inadequada, com espaços insuficientes para setores técnicos, administrativos e atendimento ao público.
- Organização institucional em processo de transição, com implementação recente de novo organograma, ainda sem infraestrutura compatível.
- Carência de ambientes apropriados para planejamento, gestão e educação permanente.
- Capacitação profissional insuficiente ou não sistematizada, especialmente em gestão, inovação e uso de tecnologias em saúde.

Causas estruturais e históricas dos problemas

- Crescimento populacional e envelhecimento acelerado, sem expansão proporcional da rede assistencial.
- Mudanças no perfil epidemiológico, com aumento de doenças crônicas e casos complexos.
- Perda de maternidades de referência para a gestão estadual, reduzindo a capacidade instalada municipal.
- Investimentos historicamente concentrados na atenção básica e urgência, com menor foco em média e alta complexidade.
- Dependência de contratos com prestadores externos, dificultando autonomia e sustentabilidade financeira.
-

Infraestrutura hospitalar antiga, construída com padrões que não atendem às exigências atuais de segurança, fluxo e tecnologia.

Consequências atuais e futuras, caso o quadro não seja revertido

- Ampliação das filas e da demora no acesso a serviços essenciais.
- Aumento da mortalidade no eixo pré hospitalar e hospitalar.
- Sobrecarga de UPAs e hospitais com casos que poderiam ser resolvidos em outros níveis.
- Maior tempo de permanência hospitalar, ocupando leitos e gerando custos adicionais.
- Crescimento da dependência da rede privada e filantrópica, com menor controle público sobre a assistência.
- Risco de colapso em áreas críticas, principalmente: oncologia, cardiologia e nefrologia.
- Desigualdades no acesso, afetando principalmente idosos, gestantes, pessoas com doenças raras ou crônicas e populações vulneráveis.
- Ineficiência na alocação de recursos públicos, com desperdícios e glosas por falhas de registro ou faturamento.
- Dificuldade de atender às diretrizes do SUS, do PPA e dos órgãos de controle.
- Perda de capacidade estratégica do município como referência estadual, prejudicando toda a macrorregião.

Em síntese, a situação atual é marcada por um sistema de saúde municipal pressionado por demandas crescentes, infraestrutura insuficiente, fragilidades na organização e gestão, dependência de prestadores externos e ausência de mecanismos robustos de monitoramento e avaliação. Esses fatores comprometem a resolutividade, a equidade e a sustentabilidade do sistema, configurando uma realidade que necessita ser transformada por meio de intervenções estruturantes, institucionais e organizacionais (a serem detalhadas nos capítulos seguintes).

1. 2. 42. **Solução:**

As soluções propostas foram definidas para responder de forma direta, estruturante e integrada às fragilidades identificadas no acesso aos serviços, na capacidade instalada, na infraestrutura física, na organização da rede, na gestão institucional e na atenção a populações vulneráveis. As ações priorizam a ampliação da oferta pública, a modernização dos espaços assistenciais e administrativos, a reorganização dos fluxos de cuidado e o fortalecimento da capacidade de gestão e governança do sistema municipal de saúde. Tais soluções estão alinhadas às diretrizes do SUS e aos Objetivos Estratégicos do PPA, em especial aos eixos de saúde, inclusão, equidade, fortalecimento institucional e modernização.

O projeto REDS+JP, também, alinha-se às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), ao Plano Municipal de Saúde (2022–2025), e ao Plano de Governo da Prefeitura de João Pessoa (2025-2028), atendendo aos princípios da regionalização, integralidade e eficiência previstos na Constituição Federal (art. 198) e na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990).

1. Ampliação e reorganização da capacidade assistencial

Para superar limitações relacionadas ao acesso oportuno, à demanda reprimida por serviços especializados e à baixa resolutividade hospitalar, serão adotadas ações voltadas à expansão e reorganização da oferta assistencial pública. Entre as principais soluções, destacam-se:

- Ampliação de leitos de internação em áreas críticas de média e alta complexidade;
- Disponibilização de serviços especializados na rede própria, reduzindo filas e dependência de prestadores externos;
- Melhoria da capacidade diagnóstica e terapêutica com oferta pública de exames e serviços de apoio clínico;
- Estruturação de unidades assistenciais com perfis definidos, permitindo melhor organização dos fluxos e hierarquização da rede.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Ampliar o acesso à saúde pública de qualidade.
OE 106 – Promover direitos humanos e inclusão social.
OE 111 – Investimentos em equipamentos sociais nas cidades.

2. Modernização, construção e requalificação da infraestrutura física de saúde

Diante da defasagem estrutural de hospitais, da inadequação de espaços e da ausência de unidades especializadas, serão implementadas soluções que promovem a modernização da infraestrutura física e tecnológica, incluindo:

- Requalificação e ampliação de unidades hospitalares existentes para adequação funcional, sanitária e tecnológica;
- Construção de novas estruturas assistenciais voltadas a serviços de alta complexidade e perfis específicos de atendimento;
- Implantação de unidades especializadas (diagnóstico por imagem, hemodiálise, geriatria, TEA);
- Adequação de ambientes segundo normas de acessibilidade, segurança e padronização de fluxos assistenciais.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Fortalecimento do SUS.
OE 111 – Infraestrutura social e urbana sustentável.
OE 113 – Qualidade de vida e bem-estar.

3. Estruturação da regulação e integração da rede de atenção

Para enfrentar a fragmentação entre níveis de atenção, a baixa integração dos sistemas e as dificuldades na gestão de filas e leitos, serão implementadas ações voltadas ao fortalecimento da regulação e à integração dos serviços, tais como:

- Estruturação de uma instância reguladora centralizada e moderna, com atuação em tempo real;
- Integração tecnológica entre atenção primária, especializada, urgência e hospitais;
- Padronização de protocolos regulatórios e clínicos para garantir continuidade do cuidado;
- Melhoria do monitoramento de leitos, filas e encaminhamentos, com suporte de ferramentas digitais.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Eficiência no Sistema Único de Saúde.
OE 302 – Fortalecimento da capacidade estatal para prestação de serviços públicos.
OE 303 – Transformação digital do governo.

4. Fortalecimento da gestão, governança e capacidade institucional

Para superar limitações estruturais e organizacionais da Secretaria Municipal de Saúde, serão adotadas soluções que modernizam a gestão e aprimoram a governança institucional, incluindo:

- Adequação e modernização da sede administrativa da saúde às novas funções e responsabilidades organizacionais;
- Estruturação de espaços específicos para planejamento, gestão, capacitação, inovação e monitoramento;
- Integração entre áreas estratégicas como planejamento, regulação, auditoria e atenção hospitalar;
- Aprimoramento da gestão de pessoas, logística, farmácia e suporte administrativo-operacional.

Alinhamento PPA:
OE 102 – Qualidade na gestão do SUS.
OE 302 – Aperfeiçoamento das capacidades estatais.
OE 303 – Digitalização e modernização dos processos públicos.

5. Expansão da atenção a populações vulneráveis e grupos prioritários

Considerando o envelhecimento acelerado da população, o aumento das condições crônicas e a necessidade de inclusão de pessoas com necessidades específicas, serão adotadas soluções que promovem equidade e cuidado integral, tais como:

- Implantação de unidades especializadas para idosos e pessoas com transtorno do espectro autista;
- Ampliação da oferta de serviços contínuos e de reabilitação;
- Adequação da rede às necessidades de grupos prioritários (gestantes, mulheres, crianças, pessoas com doenças crônicas e deficiência);
- Redução das barreiras territoriais e sociais de acesso por meio da expansão e reorganização da rede própria.

Alinhamento PPA:
OE 101 – Atenção a pessoas em vulnerabilidade social.
OE 102 – Acesso à saúde de qualidade.
OE 106 – Inclusão e proteção de grupos vulneráveis.
OE 107 – Atenção às mulheres.
OE 109 – Promoção da igualdade racial.
OE 214 – Redução das desigualdades regionais.

As soluções apresentadas constituem um conjunto integrado de ações que atuam sobre os principais fatores estruturais que limitam o desempenho da rede municipal de saúde. Ao expandir a oferta assistencial, modernizar a infraestrutura, fortalecer a regulação, aprimorar a gestão e priorizar populações vulneráveis, as intervenções propostas criam condições para reorganizar o sistema de saúde de João Pessoa com foco em acesso, qualidade, equidade e sustentabilidade. Além disso, estão plenamente alinhadas às diretrizes do SUS e aos Objetivos Estratégicos do PPA, ao PMS (2022–2025) e ao Plano de Governo da Prefeitura de João Pessoa (2025-2028) garantindo coerência institucional, aderência às políticas públicas e legitimidade federativa.

1. 2. 63. **Resultado:**

A implementação das soluções propostas permitirá a transformação estrutural, assistencial, institucional e tecnológica da rede municipal de saúde de João Pessoa, produzindo resultados diretos sobre o acesso, a qualidade do cuidado, a eficiência da gestão e a equidade, além de gerar externalidades positivas para o sistema de saúde e para a população de forma mais ampla. Os resultados esperados são observáveis, mensuráveis e alinhados às diretrizes do SUS e aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027.

1. Melhoria do acesso e ampliação da oferta de serviços de saúde

- Redução do tempo de espera para consultas, exames, procedimentos e internações.
- Aumento da capacidade de atendimento em média e alta complexidade.
- Disponibilização de serviços especializados atualmente indisponíveis ou insuficientes na rede própria.
- Maior cobertura territorial e funcional da rede assistencial.

Esses resultados contribuirão para garantir acesso mais oportuno e equitativo à população, reduzindo a demanda reprimida e promovendo maior integralidade do cuidado.

2. Aumento da resolutividade e da qualidade do cuidado

- Melhoria dos desfechos clínicos, como redução da mortalidade hospitalar e de eventos adversos.
- Diminuição do tempo médio de permanência hospitalar por maior eficiência assistencial.
- Maior proporção de atendimentos eletivos em relação às urgências.
- Fluxos assistenciais mais organizados, com continuidade do cuidado entre os níveis de atenção.

Com isso, a rede municipal terá maior capacidade de resolver demandas complexas com segurança, efetividade e foco no usuário.

3. Modernização da infraestrutura física e tecnológica da rede de saúde

- Unidades assistenciais requalificadas, ampliadas ou construídas segundo padrões sanitários, funcionais e tecnológicos atualizados.
- Ambientes acessíveis, seguros, adequados às demandas assistenciais e às normas vigentes.
- Melhor experiência do usuário e melhores condições de trabalho para os profissionais.

A modernização da infraestrutura permitirá maior eficiência operacional e aumentará a capacidade instalada do sistema público.

4. Fortalecimento da gestão, regulação e governança do sistema de saúde

- Estrutura administrativa mais adequada às atribuições da Secretaria Municipal de Saúde.
-

Regulação integrada, com monitoramento eficiente de leitos, filas e fluxos.

- Maior capacidade de planejamento, tomada de decisão e avaliação de resultados.
- Melhor articulação entre planejamento, atenção primária, especializada, urgência e hospitais.

Esses avanços fortalecem a governança do sistema e aumentam a capacidade institucional do município.

5. Ampliação da atenção a populações vulneráveis e grupos prioritários

- Disponibilização de serviços especializados para idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, pacientes crônicos e outros grupos prioritários.
- Redução das desigualdades no acesso entre territórios e perfis populacionais.
- Melhoria da qualidade do cuidado materno-infantil e das condições de saúde da mulher.
- Promoção da inclusão social e garantia de direitos no âmbito da saúde pública.

Assim, a rede de saúde torna-se mais equitativa, humanizada e alinhada às necessidades da população.

6. Maior eficiência e sustentabilidade do sistema de saúde

- Redução da dependência de prestadores privados e filantrópicos em serviços estratégicos.
- Melhoria no uso de recursos públicos por meio de infraestrutura adequada e processos gerenciais mais eficientes.
- Otimização da logística de insumos, medicamentos e serviços de apoio.
- Sustentabilidade financeira e operacional da rede no longo prazo.

Isso favorece a autonomia municipal e o uso racional dos recursos disponíveis.

7. Externalidades positivas e impactos ampliados

Além dos resultados diretos sobre a rede de saúde, espera-se a geração de benefícios mais amplos, tais como:

- Valorização do SUS municipal e fortalecimento da rede regional de saúde.
- Melhoria da confiança da população no sistema público.
- Geração de empregos diretos e indiretos durante a implantação e operação das novas estruturas.
- Aumento da capacidade de resposta a emergências sanitárias e eventos de risco.
- Contribuição para o desenvolvimento social, redução das desigualdades e melhoria da qualidade de vida.

Em síntese, as soluções propostas permitirão transformar a rede municipal de saúde de João Pessoa em um sistema mais acessível, resolutivo, moderno, integrado, inclusivo e sustentável. Os resultados esperados decorrem

diretamente das necessidades identificadas no contexto, respondem aos problemas diagnosticados e refletem o impacto positivo das ações estruturantes a serem implementadas, consolidando uma base sólida para a melhoria contínua da saúde pública no município.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral
Transformar a rede municipal de saúde, ampliando a capacidade assistencial, melhorando a qualidade do cuidado e fortalecendo a gestão, para garantir acesso equitativo e sustentabilidade do sistema, em conformidade com as diretrizes do SUS.

(ii) Objetivos Específicos

A) Ampliar e qualificar a oferta de serviços de média e alta complexidade na rede municipal de saúde, por meio da expansão da capacidade instalada e da implantação de serviços especializados, assegurando acesso oportuno, redução de filas e melhoria dos resultados assistenciais.
Indicadores:
I01A: Tempo médio de espera para consulta especializada (dias).
I02A: Tempo médio de espera para cirurgia eletiva (dias).
I03A: Percentual de internações eletivas sobre o total (%).
I4A: Tempo médio de regulação de leito (h)

B) Modernizar, requalificar e expandir a infraestrutura física e tecnológica das unidades de saúde, garantindo ambientes seguros, acessíveis, funcionais e eficientes, adequados às necessidades assistenciais e às condições de trabalho das equipes.
Indicadores:
I01B: Percentual de produção própria vs. contratada em MAC (%)

C) Fortalecer a gestão, a regulação, a governança e a sustentabilidade do sistema municipal de saúde, promovendo a integração entre os níveis de atenção, o aprimoramento dos processos administrativos e logísticos e a ampliação da atenção equitativa às populações prioritárias.
Indicadores:
I01C: Percentual de execução orçamentária da saúde (%)

I02C: Percentual de encaminhamentos da APS com retorno assistencial registrado (%)

I03C: Percentual de atendimentos a pacientes de outros municípios (%)

1. 4. **Indicadores**
1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**
Nome: I01A: Tempo médio de espera para consulta especializada (dias)

Descrição:
Mede o tempo médio, em dias, entre a data da solicitação e a realização da consulta especializada no SUS municipal. O indicador incorpora, além da capacidade instalada, a eficiência da regulação assistencial, a priorização clínica e a integração digital dos sistemas. Reflete diretamente a oportunidade de acesso e a equidade na atenção especializada.

Fórmula de cálculo:
Soma dos tempos (em dias) entre a data de solicitação e a data de realização da consulta especializada ÷ Número total de consultas realizadas no período

Unidade: Dias

Periodicidade: Mensal (monitoramento) / Anual (avaliação)

Modelo SMART:

- S: Mede acesso oportuno à atenção especializada
- M: Dados SISREG e e-SUS integrados
- A: Factível com regulação qualificada, teleconsultas e ampliação da oferta
- R: Impacta diretamente acesso, equidade e resolutividade
- T: Monitoramento contínuo com meta até 2028

Meta:

Reduzir o tempo médio de espera de 90 para 60 dias até 2028, com redução progressiva anual mínima de 10% ao ano.

Linha de base: 90 dias (2025)

Fontes: SISREG, e-SUS

Alinhamento ao PPA:
OE 102, OE 106, OE 214

Vinculação ao Projeto:
Objetivo Específico A
Componente 1 – Aprimoramento de Serviços de Saúde Pública

1. 4. 7. **Informações do 2° indicador:**
Nome: I02A – Tempo médio de espera para cirurgia eletiva (dias)

Descrição:
Mede o tempo médio entre a solicitação e a realização de cirurgias eletivas. Incorpora organização da fila cirúrgica, priorização por risco, ampliação da capacidade operatória e uso de estratégias como mutirões e contratualização qualificada. Representa a eficiência da gestão da atenção hospitalar programada.

Fórmula:
Soma dos tempos de espera (dias) para cirurgias eletivas realizadas ÷ Número total de cirurgias eletivas realizadas

Unidade: Dias

Periodicidade: Trimestral

SMART:

- S: Mede acesso a cirurgia eletiva
- M: SISREG + SIH/SUS
- A: Factível com expansão da rede e gestão da fila
- R: Reduz morbidade e melhora qualidade de vida
- T: Avaliação trimestral com meta até 2028

Meta:
Reduzir o tempo médio de espera de 180 para 90 dias até 2028, com redução mínima de 20% nos dois primeiros anos.

Linha de base: 180 dias (2025)

Fontes: SIH/SUS, SISREG

Alinhamento PPA:
OE 102, OE 106, OE 214

Vinculação:
Objetivo A
Componente 1

1. 4. 13. **Informações do 3° indicador:**
Nome: I03A – Percentual de internações eletivas sobre o total (%)

Descrição:
Mede a proporção de internações eletivas em relação ao total de internações. O indicador incorpora organização da atenção hospitalar, equilíbrio entre demanda programada e espontânea e fortalecimento da regulação. Reflete o grau de planejamento e previsibilidade da rede hospitalar.

Fórmula (corrigida):
(Número de internações eletivas ÷ Número total de internações) × 100

Unidade: Percentual (%)

Periodicidade: Trimestral / Anual

SMART:

- S: Mede planejamento hospitalar
- M: SIH/SUS + SISREG
- A: Factível com organização da rede
- R: Indica eficiência e controle assistencial
- T: Monitoramento contínuo

Meta:
Aumentar a proporção de internações eletivas em 20% até 2028.

Linha de base: 2024

Fontes: SIH/SUS, CNES, SISREG

Alinhamento PPA:
OE 102, OE 106, OE 214

Vinculação:
Objetivo A
Componente 1

1. 4. 19. **Informações do 4° indicador:**
Nome: I04A –Tempo médio de regulação de leito (h)

Descrição:
Mede o tempo entre a solicitação e a ocupação do leito. O indicador incorpora digitalização da regulação, integração dos sistemas, monitoramento em tempo real e ampliação da capacidade instalada, refletindo a eficiência do acesso hospitalar,

Fórmula:
?(Data/hora da internação ? Data/hora da solicitação) ÷ Nº total de internações reguladas

Unidade: Horas

Periodicidade: Mensal / Trimestral

Meta:
Reduzir de 12h para 6h até 2029.

Linha de base: 12h

Fontes: SISREG

Alinhamento:
OE 102, OE 106, OE 214

Vinculação:
Objetivo A

1. 4. 20. **Informações do 5° indicador:**
Nome: I01B – Percentual de produção própria versus contratada em Média e Alta Complexidade (MAC)

Descrição:
Mede a proporção da produção assistencial realizada na rede própria. Incorpora redução da dependência de prestadores contratados, expansão da infraestrutura e aumento da autonomia do sistema municipal.

Fórmula:
(Produção MAC na rede própria ÷ Produção total MAC) × 100

Meta:
Alcançar 80% até 2027

Linha de base: 61,9%

Fontes: SIA/SUS, SIH/SUS

Alinhamento:
OE 102, OE 111, OE 302, OE 303

Vinculação:
Objetivo B
Componentes 1 e 2

1. 4. 21. **Informações do 6° indicador:**
Nome: I01C – Percentual de execução orçamentária da saúde (%)

Descrição:
D

Mede a capacidade de execução do orçamento da saúde. Incorpora fortalecimento da governança, planejamento financeiro e eficiência do gasto público.

Fórmula:
(Despesa liquidada ÷ Orçamento autorizado) × 100

Meta:
Alcançar ? 90% até 2029.

Linha de base: 80%

Fontes: SIOPS, relatórios financeiros

Alinhamento:
OE 102, OE 302, OE 303, OE 306

Vinculação:
Objetivo C
Componente 2 e 3

1. 4. 22. **Informações do 7° indicador:**
Nome: I02C: Percentual de encaminhamentos da APS com retorno assistencial registrado (%)

Descrição:
Mede a proporção de usuários encaminhados pela Atenção Primária à Saúde (APS) para serviços especializados que possuem retorno assistencial registrado à equipe de origem, evidenciando a coordenação do cuidado e a integração entre os níveis de atenção. O indicador incorpora fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS), com foco na continuidade do cuidado, comunicação entre equipes e resolutividade do sistema.

Fórmula de cálculo:
(Número de encaminhamentos da APS para atenção especializada com retorno registrado à APS ÷ Número total de encaminhamentos da APS para atenção especializada) × 100

Unidade de medida: Percentual (%)

Periodicidade: Semestral / Anual

Modelo SMART

- S (Específico): Mede a integração entre APS e atenção especializada
- M (Mensurável): Dados obtidos por meio do SISREG, e-SUS e sistemas próprios de regulação
- A (Atingível): Factível com implantação de protocolos, regulação integrada e prontuário eletrônico
- R (Relevante): Essencial para coordenação do cuidado, continuidade assistencial e eficiência da rede
- T (Temporal): Monitorado semestralmente, com metas progressivas até 2028

Meta:
Alcançar ? 70% de encaminhamentos com retorno registrado à APS até 2028, com evolução progressiva:

- 2026: ? 50%
- 2027: ? 60%

- 2028: ? 70%

Linha de base

Ausência de registro sistematizado

Fontes de dados

- SISREG
- e-SUS APS
- Sistemas municipais de regulação e prontuário eletrônico

Alinhamento ao PPA

- OE 102 – Acesso e qualidade do SUS
- OE 106 – Equidade e integralidade do cuidado
- OE 302 – Fortalecimento da gestão
- OE 303 – Transformação digital

Vinculação ao Projeto

- **Objetivo Específico C** – Fortalecimento da gestão, regulação e governança
- **Componente 2 –** Fortalecimento Institucional

1. 4. 40. **Informações do 8° indicador:**
Nome: I03C: Percentual de atendimentos a pacientes de outros municípios (%)

Descrição:
O percentual de atendimentos a pacientes de outros municipios está alinhado às pactuações interfederativas vigentes no âmbito da CIR e da CIB, garantindo a organização regional do acesso.

Fórmula:
(Nº de atendimentos a pacientes não residentes ÷ Nº total de atendimentos) × 100

- Linha de base: atualmente não monitorada
- Periodicidade: anual

Meta:
Ampliar participação regional ? 25% até 2028

Fonte: CNES, SIH/SUS, SIA/SUS

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Aprimoramento de Serviços de Saúde Pública
Valor estimado em Dólar (USD): 90.428.616,00

Descrição:
O Componente 1 visa promover a transformação estrutural da rede municipal de saúde por meio da construção, reforma, ampliação, implantação e adequação de unidades assistenciais de média e alta complexidade, bem como da criação de serviços especializados estratégicos para o aumento da capacidade instalada e da resolutividade do sistema junto a modernização na aquisição de equipamentos para a assistência em saúde pública no município de João Pessoa. Essas intervenções respondem diretamente às limitações identificadas no diagnóstico situacional, tais como a insuficiência de leitos públicos, a obsolescência de estruturas físicas, a escassez de serviços especializados, a dependência de prestadores privados, a sobrecarga das urgências e a elevada demanda reprimida por consultas, exames e procedimentos.

As ações deste componente estão alinhadas às soluções propostas para ampliar a oferta de serviços, qualificar o cuidado, modernizar a infraestrutura hospitalar, organizar fluxos assistenciais e reduzir desigualdades no acesso. As obras e implantações previstas permitirão a oferta de novos serviços estratégicos (como hemodiálise, oncologia, geriatria, diagnóstico por imagem e cuidados a pessoas com TEA), além de fortalecer hospitais de referência municipal e regional, considerando que João Pessoa é executante de referência para toda a 1ª Macrorregião além de outros municípios da 2ª e 3ª macrorregião de saúde do estado da Paraíba. Dessa forma, o componente contribuirá diretamente para os resultados esperados do programa: ampliação do acesso, redução de filas e tempo de espera, aumento da resolutividade, melhoria dos desfechos clínicos, fortalecimento da rede própria e sustentabilidade do sistema.

O componente também reforça a capacidade do município de João Pessoa em assumir seu papel como polo de média e alta complexidade na macrorregião, reduzindo a necessidade de encaminhamentos externos e aumentando a autonomia do SUS municipal. As intervenções estruturais previstas serão desenvolvidas de acordo com normas sanitárias, critérios de segurança, acessibilidade, eficiência operacional e qualidade do cuidado, garantindo ambientes adequados tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 1.1 Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia

Valor estimado: $1.858.000,00

Descrição: A ação compreende a elaboração de estudos técnicos preliminares, projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia necessários para a viabilização das obras estruturantes previstas no Componente 1, incluindo hospitais, policlínicas, Sede do SAMU, unidades especializadas e sedes administrativas. Os projetos garantirão a adequada concepção, dimensionamento e planejamento das intervenções, otimizando prazos, custos e qualidade das execuções, além de permitir o detalhamento técnico necessário para as etapas de licitação, contratação e fiscalização das obras. A ação inclui a contratação de consultorias especializadas em engenharia civil, elétrica, hidráulica, sanitária e hospitalar, bem como assessoria técnica para compatibilização e análise de viabilidade ambiental e urbanística.

Meta: Elaborar e aprovar 100% dos estudos e projetos de arquitetura e engenharia necessários às obras do Componente 1 até 2026, garantindo a compatibilidade técnica, legal e ambiental de todas as intervenções.

Da Intervenção

Elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental

Desenvolvimento de projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia (civil, elétrica, hidráulica, estrutural, climatização e hospitalar)

Compatibilização de projetos com o Plano Diretor de Obras da Saúde e diretrizes do Ministério da Saúde

Apoio técnico para elaboração de memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e estimativas de custos conforme TCU

Análise e aprovação técnica dos projetos junto aos órgãos competentes (Vigilância Sanitária, SEMAM, CREA, Corpo de Bombeiros)

Adoção de princípios de sustentabilidade, eficiência energética e acessibilidade universal;

(P) 1.2 Aquisição de equipamentos Hospital oncológico

Valor estimado: $ 9.960.400,00

Descrição: A ação prevê a aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários técnicos e tecnológicos de alta complexidade para o novo Hospital Oncológico de João Pessoa. A medida é essencial para garantir o funcionamento pleno e a qualidade assistencial da unidade, contemplando desde os setores de diagnóstico e tratamento até as áreas administrativas e de ensino. Os equipamentos previstos incluem itens para o centro cirúrgico oncológico, UTI, hospital-dia, quimioterapia, radioterapia, diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas, anatomia patológica, ambulatórios especializados e suporte terapêutico. Serão priorizados equipamentos com tecnologia de ponta, interoperáveis e compatíveis com os

sistemas digitais do SUS, assegurando rastreabilidade, segurança e eficiência na gestão hospitalar.

Meta: Adquirir, instalar e colocar em operação 1.327 equipamentos necessários à implantação (anexo) e funcionamento do Hospital Oncológico até 2028, garantindo a plena capacidade operacional da unidade, conforme cronograma físico-financeiro do projeto.

Da Intervenção

Aquisição de equipamentos médico-hospitalares (diagnóstico por imagem, UTI, centro cirúrgico, oncologia clínica e hospital-dia)

Instalação de sistemas de radioterapia (acelerador linear e suporte de proteção radiológica)

Aquisição de equipamentos laboratoriais e de patologia clínica

Equipamentos de informática

Capacitação de equipes para uso, manutenção e gestão dos equipamentos adquiridos

Implantação de protocolos de manutenção preventiva e corretiva, conforme normas da ANVISA e Ministério da Saúde.

(P) 1.3 – Construção do Hospital Oncológico

Valor estimado: $ 42.806.240,00

Descrição: O projeto contempla a construção de um hospital de perfil oncológico, com área total estimada de 17.000,00 m², e capacidade para 150 leitos (incluindo leitos clínicos, cirúrgicos, UTI adulto e oncológicos), o qual tem como avaliação do terreno previsto no valor de U$ 1.930.240,00. O hospital contará com centro cirúrgico oncológico, hospital-dia, quimioterapia, radioterapia (se incorporado), diagnóstico por imagem, patologia clínica, ambulatório especializado e suporte terapêutico. O Hospital oncológico atuará como unidade de referência para tratamento do câncer e atenção a condições de média e alta complexidade, reduzindo a demanda reprimida, o tempo de espera para diagnóstico e tratamento e os encaminhamentos para outros municípios. A construção do HGC impactará diretamente na melhoria dos desfechos clínicos e na redução da mortalidade por câncer.

Meta: Construir e implantar 01 hospital com perfil oncológico público no município de João Pessoa integrado às RAS e à Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS. Com a implantação de um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) público, moderno e digitalmente integrado, para atendimento de média e alta complexidade.

Da Intervenção Construção de:

Setor	Estrutura Física (estimada)			Observações
Internação geral e oncológica	150 leitos oncológicos (com 40 cirúrgicos + 20 UTI) - leitos onco Pediátrico e Adulto			Total 150 leitos
Centro cirúrgico	6 salas cirúrgicas (2 oncológicas)			Alta complexidade

Hospital-dia e quimioterapia	30 poltronas			Tratamento ambulatorial
Radioterapia	1 acelerador linear			Habilitação CNES Oncologia
Centro de Diagnóstico por imagem	TC, RM, mamografia digital, ultrassom (proposta de locação de equipamentos)			Diagnóstico e controle
Laboratório de análise clínicas (marcadores tumores); de análise Patologia clínica e anatomia patológica	1 laboratório completo			Diagnóstico e controle
Ambulatório especializado	20 consultórios			Multidisciplinar, Diagnóstico e controle
Administração e ensino/pesquisa	Auditório, biblioteca, salas de residentes			

(P) 1.4 – Construção da Unidade de Referência TEA

Valor estimado: $ 1.879.672,00

Descrição: Construção de 01 unidade especializada para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com área de 1.392,00 m², o qual tem como avaliação do terreno previsto no valor de U$579.072,00. A unidade oferecerá diagnóstico, intervenção precoce, terapias multiprofissionais

(fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia), apoio às famílias e articulação com educação e assistência social. A ação responderá à carência de oferta especializada no município, garantindo inclusão, equidade, integralidade do cuidado e cumprimento das diretrizes nacionais para atenção às pessoas com TEA.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de desenvolvimento neurológico que exige atenção integral, multiprofissional e contínua.

- A ausência de unidades integradas de atendimento a pessoas com TEA compromete o diagnóstico precoce, o acompanhamento terapêutico e a inclusão social.

- A unidade reforçará os princípios da integralidade, equidade e inclusão social, integrando saúde, educação e assistência social.

Meta: Construir 01 unidade pública de referência ao TEA, garantindo acesso, diagnóstico precoce, acompanhamento terapêutico e apoio às famílias.

Da Intervenção:

1. Demolição do prédio antigo;

2. Reforma estrutural das áreas já existentes (consultórios, recepção, sanitários acessíveis, áreas técnicas);

3. Ampliação para implantação de novos espaços funcionais:

   06 consultórios multiprofissionais (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, neuropediátrica, enfermagem especializada); 02 salas de integração sensorial e motricidade; 02 salas de terapia em grupo/oficinas; Sala de capacitação e apoio às famílias; Espaço de convivência e recreação terapêutica; Setor administrativo e apoio técnico-operacional (esterilização, almoxarifado, copa, vestiário e sanitários); 02 Elevadores, Implantação da energia solar.

(P) 1.5 – Aluguel de hospital provisório (momento da reforma e ampliação do HMSI)

Valor estimado: $650.300,00

Descrição: Durante a execução das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), será necessária a locação temporária de uma unidade hospitalar provisória, devidamente equipada, para garantir a continuidade dos serviços hospitalares essenciais, especialmente nas áreas de cardiologia, cirurgia geral, retaguarda das UPAS.

Meta: Aluguel de 01 hospital provisório para assegurar a continuidade da assistência hospitalar do HMSI durante o período de reforma e ampliação, mantendo o perfil de atendimento e a qualidade dos serviços prestados à população, sem interrupção das internações e procedimentos hospitalares essenciais.

Relação com a Solução Proposta: Conforme a necessidade de responder diretamente às limitações atuais de infraestrutura e à insuficiência de leitos e serviços especializados, no momento em que o HMSI estiver em adequações estruturais na reforma e ampliação haverá um suporte de garantir a continuidade da assistência no perfil da Unidade Hospitalar, sendo referência cardiológica.

Da Intervenção

- Locação de imóvel hospitalar adequado, com estrutura física compatível para funcionamento temporário
- Adequação de instalações provisórias às normas sanitárias da Anvisa e de segurança assistencial
- Remanejamento de equipamentos e equipes do HMSI para a unidade provisória
- Garantia de manutenção da oferta de leitos e continuidade das internações de média e alta complexidade

Responde à necessidade de garantir a funcionalidade da rede hospitalar municipal enquanto ocorrem intervenções estruturais de grande porte no HMSI.

A medida evita desassistência e sobrecarga de outros estabelecimentos de saúde, assegurando:

- A manutenção dos fluxos assistenciais e da retaguarda cardiológica e cirúrgica
- A integração temporária da unidade provisória à regulação municipal e regional
- A otimização do uso de recursos e equipamentos existentes

(P) 1.6 – Reforma e ampliação do Hospital Municipal Santa Isabel

Valor estimado: $18.858.900,00

Descrição: A intervenção consiste na reforma e ampliação do HMSI, unidade hospitalar de média e alta complexidade. O novo hospital contará com ampliação de 70 leitos para retaguarda, além de modernização e adequações físicas, como lavanderia, a central de abastecimento farmacêutica, área externa, fachada e asfaltar área de estacionamento. Com ampliação e reforma do bloco de nefrologia, com 64 cadeiras novas, totalizando 100 cadeiras, ambulatório de pré e pós transplante, junto a implantação de sala cirúrgica para pequenos procedimentos.

Com a reforma e ampliação, na área da nefrologia, oferecerá terapia renal substitutiva para pacientes com doença renal crônica, atualmente dependentes de serviços privados ou de deslocamentos para outros municípios. Essa ação fortalecerá a autonomia do município no cuidado de pacientes renais crônicos.

Meta: Garantir a 1 ampliação e reforma com qualificação do acesso hospitalar no município, por meio de uma estrutura moderna, segura e resolutiva, promovendo o fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências e da Atenção Especializada, junto à Atenção à Doenças Renal Crônica, alinhada às diretrizes do SUS e às necessidades do território.

Relação com a Solução Proposta: O projeto responde diretamente às limitações atuais de infraestrutura e à insuficiência de leitos e serviços especializados. A reforma e ampliação e a incorporação de tecnologias inovadoras permitirão melhor gestão de leitos, redução de filas e otimização dos fluxos de pacientes, integrando-se à regulação municipal e regional. A modernização dos equipamentos e ambientes hospitalares aumentará a eficiência operacional e a segurança do paciente, assegurando um ambiente humanizado e sustentável. O município de João Pessoa (PB), capital, conta com população estimada em mais de 850 mil habitantes (IBGE 2024) e representa o principal polo de atenção terciária do Estado. Entretanto, observa-se insuficiência na oferta pública municipal de tratamento dialítico, o que tem gerado:

- Dependência de serviços contratualizados privados e deslocamentos frequentes de pacientes para outros municípios
- Altas taxas de judicialização para garantir acesso à terapia renal substitutiva (TRS)
- Sobrecarga de unidades privadas conveniadas ao SUS e maior custo assistencial por paciente.

Da Intervenção

- Área de ampliação de 7.772,00 m²,com a área da Nefrologia
- Reforma de: 3.454,00m²
- 64 cadeiras de Hemodiálise
- Ambulatório de pré e pós transplantes
- Centro de pequenas cirurgias p fístulas
-

lavanderia; central de abastecimento farmaceutico

- ampliação 70 leitos
- Implantação como Hospital de ensino
- Implantação da energia solar
- pintura da fachada; rebocagem da área de trás e lado direito
- asfaltar as ruas internas (4.000m²); jardinagem.

(P) 1.7 - Sede do SAMU

Valor estimado: $1.511.784,00

Descrição: A ação consiste na construção de uma nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) em João Pessoa, estrategicamente localizada para ampliar a cobertura territorial e reduzir o tempo-resposta das ocorrências de urgência e emergência. A intervenção contempla a edificação de estrutura física moderna e sustentável, com áreas administrativas, alojamentos para as equipes, garagem para ambulâncias, central de regulação local e infraestrutura de apoio técnico e logístico para o atendimento pré-hospitalar móvel, o qual tem como avaliação do terreno previsto no valor de U$ 582.784,00.

Meta: Construir e implantar 01 Base do SAMU em João Pessoa até 2028, garantindo cobertura operacional integral 24h, com capacidade para abrigar equipes multiprofissionais e frota de ambulâncias tipo A, B e D. A meta inclui reduzir o tempo médio de resposta das ocorrências urbanas para até 10 minutos e das ocorrências periféricas para até 15 minutos.

Objetivo do Componente: Fortalecer a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) do município de João Pessoa, assegurando a estruturação física e operacional do SAMU 192 para resposta rápida, integrada e eficiente às situações de urgência, reduzindo a mortalidade evitável e qualificando o cuidado pré-hospitalar.

Da Intervenção

Construção de nova base do SAMU com área total estimada de 1.000,00 m²

Estrutura física com salas de regulação local, coordenação, repouso adequado e refeitório para equipes

Garagem coberta para as ambulâncias

Oficinas e almoxarifado para manutenção de equipamentos e insumos

Instalação de sistema de energia solar

(P) 1.8 Construção da Policlínica do Idoso

Valor estimado: $1.755.320,00

Descrição:

A Policlínica do Idoso será uma unidade especializada de atenção ambulatorial integrada para pessoas com 60 anos ou mais, com área de 1.390,00 m² (valor venal do terreno de U$454.720,00) . Oferecerá consultas multiprofissionais (geriatra, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia), exames complementares, reabilitação, acompanhamento de doenças crônicas, prevenção de quedas e cuidado centrado na funcionalidade. Essa unidade responderá diretamente ao envelhecimento populacional e à necessidade de atenção especializada ao idoso, promovendo a continuidade do cuidado, reduzindo hospitalizações evitáveis e melhorando a qualidade de vida dessa população.

A unidade atuará como ponto de atenção secundária, articulada à Atenção Primária, aos Centros de Reabilitação, hospitais gerais e às redes de atenção psicossocial e crônica.

A Policlínica do Idoso constitui um investimento estratégico na reorganização da atenção à saúde da pessoa idosa, promovendo:

- Integralidade e continuidade do cuidado
- Prevenção de incapacidades e hospitalizações
- Promoção da funcionalidade e envelhecimento ativo
- Integração intersetorial com assistência social e cultura
- Sustentabilidade do SUS diante do envelhecimento populacional.

Meta: Construir e implantar 01 Policlínica do Idoso para atenção ambulatorial especializada, multiprofissional e integrada, com foco em funcionalidade, prevenção e reabilitação.

Da Intervenção Construção:

- Demolição do prédio antigo
- Consultórios médicos e multiprofissionais
- Salas de acolhimento, reabilitação e atividades coletivas
- Sala de observação e curativos
- Apoio diagnóstico;
- Espaço para educação permanente e apoio ao autocuidado
- Implantação da energia solar; Elevador.

(P) 1.9 – Reforma e ampliação do Complexo Hospitalar de Mangabeira Gov. Tarcísio Burity

Valor estimado: $5.574.000,00

Descrição: A intervenção prevê a reforma estrutural e a ampliação do Complexo Hospitalar de Mangabeira, com readequação de áreas físicas, modernização de instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de 30 leitos, unificação do centro cirúrgico com capacidade de 10 cirurgias simultâneas, implantação ou ampliação de UTI com 20 leitos, modernização de equipamentos e reorganização de fluxos assistenciais. A ampliação da unidade permitirá aumento da capacidade hospitalar, melhoria da qualidade assistencial, redução de superlotação e maior resolutividade de urgências e internações. Este hospital é estratégico como referência regional e sua modernização é fundamental para atender a demanda crescente e evitar encaminhamentos externos.

Meta: Reforma e ampliação de 01 Hospital, CHMTB, fortalecendo a capacidade de resposta hospitalar da rede pública, qualificando a atenção às urgências, emergências e internações de média e alta complexidade, com foco na integralidade da assistência, eficiência operacional e segurança do paciente.

Relação com a Solução Proposta: A reestruturação do Complexo Hospitalar de Mangabeira é solução estruturante para reduzir a superlotação da rede hospitalar, otimizar fluxos de referência e contra-referência, e fortalecer o papel da unidade como hospital regional estratégico na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e na Rede de Atenção às Condições Crônicas (RAC).

O projeto contribuirá para o equilíbrio entre a oferta e a demanda assistencial, reduzindo encaminhamentos a outros municípios e racionalizando custos operacionais.

Da Intervenção

Reforma estrutural e modernização das instalações físicas

Atualização das redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais;

Ampliação da capacidade instalada, com a área 3.728,00 m²

Requalificação do centro cirúrgico, com a implantação de salas inteligentes e sistemas integrados de monitoramento

Aquisição e modernização de equipamentos hospitalares, priorizando tecnologia com interoperabilidade digital, conforme diretrizes do Programa SUS Digital 2025-2026

Reorganização dos fluxos assistenciais e logísticos, com implantação de gestão de risco clínico e protocolos de segurança do paciente

Implantação da energia solar

(P) 1.10– Reforma e ampliação do Hospital Municipal Valentina (HMV)

Valor estimado: $5.574.000,00

Descrição: A ação contempla a reforma e ampliação do HMV, unidade de média complexidade, com área de 2.230,00 m² reformada e 1.500,00 m² ampliada, criação ou expansão de 20 leitos, modernização do pronto atendimento, centro cirúrgico, áreas de internação, diagnóstico e apoio. O HMV desempenha papel fundamental na oferta de serviços hospitalares para a população de seu território e para a rede municipal. A reforma e ampliação permitirão melhorar a infraestrutura física, aumentar a capacidade instalada, reorganizar fluxos, reduzir internações por urgência em outras unidades e fortalecer a rede própria de hospitais do município.

Meta: Reforma e ampliação de 01 Hospital, HMV, fortalecendo a capacidade do único hospital pediátrico da gestão própria do município, qualificando o atendimento de média complexidade e a articulação com as redes de atenção à saúde, de modo a aumentar a resolutividade dos serviços locais, reduzir internações evitáveis em outras unidades e garantir o cuidado integral à população adscrita.

Da Intervenção

- Área de reforma: 2.230,00 m² (infraestrutura física existente)
- Área de ampliação: 1.500,00 m² (novas edificações)
- Capacidade instalada após ampliação: criação ou expansão de 20 novos leitos hospitalares
- Modernização do Pronto Atendimento
- Ampliação e adequação do Centro Cirúrgico
- Requalificação das Áreas de Internação (masculina, feminina e pediátrica)
- Atualização das áreas de Diagnóstico e Apoio (imagem, laboratório e farmácia)
- Adequações de acessibilidade, instalações elétricas, hidráulicas e de climatização hospitalar
- Implantação de sistemas de segurança e controle de infecção (ventilação, isolamento, áreas limpas/sujas)
- Jardinagem; Asfalto no estacionamento; Nova Fachada no padrão modernizado.

1. 5. 4. **Informações do 2° componente:**
Nome: Fortalecimento Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 29.634.384,00

Descrição:
O Componente 2 tem como objetivo modernizar e fortalecer a gestão da saúde pública no município de João Pessoa/PB, promovendo maior eficiência operacional, integração digital, qualificação profissional e certificação da qualidade hospitalar. As intervenções deste componente visam reduzir gargalos administrativos e aprimorar a logística, o controle e a regulação dos serviços de saúde, garantindo maior transparência e eficiência na alocação de recursos.

Os produtos abaixo detalham as ações estratégicas planejadas dentro do Componente 2.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P2.1) Aluguel de estrutura provisória para atender a Sede

Valor estimado: $278.700,00

Descrição: Durante o período de reforma e modernização da sede da SMS-JP, será necessária a locação temporária de imóvel adequado para garantir a continuidade das atividades administrativas e operacionais da Secretaria. A estrutura provisória deve atender às normas de acessibilidade, segurança e eficiência, permitindo que a SMS mantenha o funcionamento pleno dos setores essenciais e o atendimento ao público.

Meta: Locar 01 imóvel provisório devidamente adaptado e operacional para funcionamento da SMS-JP durante o período das obras, sem prejuízo aos serviços e atividades institucionais.

Objetivo do Componente: Garantir a continuidade dos serviços administrativos e operacionais da SMS-JP durante as obras de reforma e modernização, evitando interrupções e perdas de eficiência.

Da Intervenção:

- Locação de imóvel com estrutura adequada para abrigar todos os departamentos e setores da SMS;
- Adequação mínima das instalações para rede lógica, mobiliário e acessibilidade;
- Garantia de condições sanitárias, elétricas e de segurança;
- Integração do espaço provisório aos sistemas digitais e de comunicação da SMS.

(P) 2.2 - Construção da nova Sede da SMS-JP

Valor estimado: $12.943.712,00

Descrição: A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS/JP), alinhada à nova Lei Ordinária Municipal de 2025, vem promovendo a atualização de sua estrutura organizacional e modelo de gestão, com o objetivo de modernizar processos, integrar áreas e garantir melhor atendimento à população. A atual sede apresenta limitações estruturais, tecnológicas e logísticas incompatíveis com a nova configuração administrativa e as exigências legais dos órgãos de controle (TCU, CGU, MS e CNS). Ademais, o prédio sofreu desgastes e não atende mais aos requisitos de segurança, acessibilidade e eficiência energética. A proposta visa a construção de uma nova sede, em área de terreno com valor venal de R$ 928.000,00, a ser moderna, sustentável e inteligente, com condições adequadas de trabalho e integração dos serviços essenciais da saúde municipal, incluindo o Complexo Regulador Municipal de João Pessoa.

Meta: Garantir uma gestão moderna, integrada, eficiente e orientada ao cidadão, por meio da construção de 01 nova sede da SMS/JP.

Relação com a Solução Proposta:

- Unificar e modernizar os espaços administrativos e operacionais da SMS/JP;
- Integrar o Complexo Regulador Municipal (Central Ambulatorial, Central Hospitalar, Central de Urgência e Emergência e Cartão SUS);
- Integrar a Vigilância Sanitária
- Otimizar fluxos de trabalho e fortalecer a governança em saúde;
- Garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e melhoria no atendimento à população;

Da Intervenção

Fortalecer a capacidade institucional e gerencial da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando a eficiência administrativa, a integração de processos e a qualidade do atendimento ao cidadão.

- Demolição do prédio em uso;
- Adequação estrutural ao novo organograma, elétrica, hidráulica e de rede lógica;
- Instalação de sistemas de energia solar e climatização inteligente;
- Implantação de rede de fibra óptica e integração digital com unidades da rede;

Localização

O projeto segue no terreno atual a ser demolido para nova construção.

(P2.3) Capacitação e Educação Permanente em Gestão da Saúde

Valor estimado: $ 5.109.500,00

Descrição: Implementação de um programa de capacitação e educação permanente voltado à formação e atualização de 2.750 profissionais de saúde por ano, ao longo de quatro anos, com foco em gestão hospitalar, planejamento em saúde, regulação, auditoria, governança clínica, economia da saúde e gestão de riscos.

Meta: Capacitar 11.000 profissionais até 2030 (2.750/ano), em diferentes níveis de gestão e assistência. Certificar ao menos 80% dos participantes com aproveitamento superior a 70%. Implementar 05 programas de educação permanente alinhados às necessidades identificadas no Plano Municipal.

Objetivo do Componente: Aprimorar a governança e a capacidade de gestão do SUS, qualificando gestores e trabalhadores para o planejamento, execução e avaliação de políticas públicas de saúde, com base em evidências científicas, indicadores de desempenho e metodologias de melhoria contínua.

Da Intervenção

Por ano, 2.750 profissionais, totalizando 11.000 profissionais.

Modalidades de execução:

- Cursos de curta e média duração (40h a 180h);
- Programas de certificação em gestão pública e hospitalar;

- Oficinas regionais de planejamento e governança clínica;
- Implementação de plataforma digital de aprendizagem contínua.

(P) 2.4 - Construção das sedes administrativas dos Distritos Sanitários

Valor estimado: $ 11.302.472,00

Descrição: As sedes dos Distritos Sanitários (DS) de João Pessoa atualmente funcionam em imóveis locados e sem infraestrutura adequada para garantir a plena execução das funções de gestão territorial, vigilância em saúde e apoio técnico às equipes da Atenção Primária. O projeto propõe a construção de seis sedes próprias em modelo arquitetônico padronizado, sustentável e acessível, integradas à rede da Secretaria Municipal de Saúde e com infraestrutura para ações intersetoriais e coordenação da Rede de Atenção à Saúde, com terrenos avaliados no valor de U$ 6.657.472,00.

Meta: Construir e colocar em funcionamento 06 sedes de Distritos Sanitários até 2029, equipadas e conectadas ao sistema de informação municipal.

Objetivo do Componente: Fortalecer a gestão descentralizada do SUS no território, ampliando a capacidade administrativa, técnica e logística dos Distritos Sanitários para coordenar a Atenção Primária, Vigilância em Saúde e as Redes de Atenção de forma integrada e eficiente.

Da Intervenção

Construção das 06 sedes administrativas de distritos com 600,00m² de área cada, de forma padronizadas, em áreas estratégicas junto às unidades de saúde da área.

1. 5. 22. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 3.937.000,00

Descrição:
O Componente 3 tem como objetivo estruturar e fortalecer a governança do Reorganização e Expansão a garantir o Direito à Saúde em João Pessoa - REDS+JP, garantindo sua gestão eficiente e monitoramento contínuo. A implementação desse componente envolve a criação de mecanismos de planejamento, supervisão e avaliação de impacto das ações executadas, assegurando transparência e efetividade na aplicação dos recursos.

A administração e avaliação do programa permitirão a adoção de boas práticas na execução das iniciativas, viabilizando o acompanhamento dos resultados e a implementação de ajustes necessários para otimizar o desempenho do programa.

Esse componente também prevê a contratação de equipe técnica qualificada para apoiar a gestão do REDS+JP, além da realização de estudos de impacto e monitoramento das ações previstas.

Objetivo do Componente: Garantir a estruturação, o gerenciamento e o acompanhamento contínuo do REDS+JP, promovendo maior controle e eficiência na execução do programa e assegurando que os investimentos realizados resultem em melhorias efetivas na rede de saúde municipal.

Relação com a Solução Proposta: A implementação desse componente responde à necessidade de fortalecimento da gestão do programa, garantindo um acompanhamento rigoroso das ações e possibilitando a correção de eventuais desvios na execução. O desenvolvimento de estratégias de monitoramento e avaliação permite uma gestão mais transparente e eficiente, promovendo a utilização otimizada dos recursos disponíveis.

Relação com os Resultados Esperados: A estruturação adequada da administração e avaliação do programa possibilitará uma implementação mais eficaz das ações previstas no REDS+JP, permitindo a mensuração dos impactos alcançados e a melhoria contínua das políticas públicas de saúde. Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- Maior eficiência na gestão e execução do programa.
-

Monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho.

- Melhor transparência na aplicação dos recursos.
- Identificação de boas práticas e oportunidades de melhoria.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 3.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social

A supervisão técnica, ambiental e social será realizada por empresa de consultoria especializada contratada pelo Município, com a finalidade de assegurar a conformidade das obras, instalações e serviços do Programa com os projetos executivos, especificações técnicas, normas sanitárias aplicáveis, legislação vigente e requisitos ambientais e sociais do BID. A supervisão abrangerá todas as intervenções do Programa, incluindo construção, reconstrução, reforma e ampliação de unidades de saúde, implantação de serviços especializados e instalações complementares.

A consultoria atuará de forma integrada com a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e com a fiscalização do Município, executando, no mínimo, as seguintes atividades.

1. Disponibilizar equipe técnica multidisciplinar e pessoal de apoio para acompanhar a implantação e execução das intervenções, incluindo especialistas em engenharia civil, arquitetura, instalações prediais (elétrica, hidrossanitária, gases medicinais, climatização), segurança contra incêndio, planejamento e custos, além de especialistas ambientais e sociais.

2. Realizar acompanhamento e controle físico, técnico e de qualidade das obras e instalações, verificando medições, conformidade com projetos, compatibilização de disciplinas, atendimento a requisitos de acessibilidade, funcionalidade assistencial e segurança do paciente.

3. Validar cronogramas físico-financeiros, registrar evolução de avanço físico, identificar desvios e recomendar medidas corretivas, com comunicação imediata à UGP em caso de não conformidades, riscos de atraso, problemas de qualidade ou eventos críticos.

4. Coordenar e verificar o Plano de Gerenciamento Ambiental e Social das obras, incluindo controle de poeira, ruído, tráfego, segurança de canteiro, gestão de resíduos da construção, destinação adequada de resíduos e efluentes, e, quando aplicável, aspectos específicos de saúde, como gestão de Resíduos de Serviços de Saúde e medidas de controle de infecção durante a execução de obras em unidades em funcionamento.

5. Monitorar condições de trabalho, saúde e segurança ocupacional, cumprimento de obrigações trabalhistas e a implementação de medidas de prevenção de acidentes, com registro de ocorrências e recomendações.

6. Apoiar a gestão de interface com a comunidade e usuários, incluindo sinalização, comunicação de obras, organização de acessos e funcionamento provisório de unidades, quando necessário, bem como apoiar a implementação de mecanismos de ouvidoria e tratamento de reclamações relacionadas às obras.

7. Executar ensaios e verificações de qualidade compatíveis com obras prediais e instalações de saúde, por meio de laboratórios e testes aplicáveis, incluindo controle tecnológico de concreto e argamassas, testes de estanqueidade, comissionamento de sistemas prediais críticos, aferições de desempenho e conformidade de instalações.

8. Emitir laudos e pareceres técnicos relativos aos serviços executados, incluindo registros fotográficos, checklists de conformidade, relatórios de não conformidade e planos de ação.

9.

Elaborar relatórios mensais de acompanhamento consolidando avanço físico, medições, resultados de testes e verificações, riscos e pendências, comparativo com cronograma e orçamento, e recomendações gerenciais para a UGP.

10. Subsidiar a UGP nos processos de recebimento provisório e definitivo, com verificação de “as built”, manuais, garantias, treinamento operacional e plano de manutenção dos sistemas implantados, quando aplicável.

Valor estimado: US$ 2.787.000,00.

(P) 3.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Este produto financiará o apoio técnico, administrativo e especializado necessário para estruturação e funcionamento da UGP, responsável pela coordenação, planejamento, gestão e monitoramento do Programa, assegurando o cumprimento das disposições do Contrato de Empréstimo do BID e a execução eficiente das ações.

O apoio à UGP compreende, no mínimo.

1. Apoio à gestão de aquisições e contratações conforme políticas e procedimentos do BID, incluindo elaboração de planos de aquisições, termos de referência, especificações técnicas, minutas, gestão de contratos e acompanhamento de entregas.

2. Apoio à gestão financeira e contábil do Programa, incluindo desembolsos, controle orçamentário, conciliações e prestação de contas.

3. Apoio ao monitoramento e avaliação, incluindo consolidação de informações, acompanhamento de indicadores e resultados, elaboração de relatórios gerenciais e apoio à preparação de missões e revisões do BID.

4. Apoio à gestão ambiental e social, garantindo integração dos requisitos E&S aos processos de contratação, supervisão e execução, incluindo instrumentos de gestão, monitoramento e registro.

5. Apoio jurídico-administrativo, comunicação institucional e transparência, incluindo rotinas de divulgação de informações e articulação intersetorial.

6. Apoio à gestão de riscos, integridade e controles internos, com mecanismos de prevenção e tratamento de inconformidades.

Valor estimado: US$ 1.000.000,00.

(P) 3.3 - Avaliações do Programa

Este produto financiará a realização de avaliações do Programa, com a finalidade de verificar o grau de alcance dos resultados e a efetividade das intervenções, subsidiando decisões de ajuste durante a implementação e a prestação de contas ao BID e à sociedade.

Valor estimado: US$ 50.000,00

(P) 3.4 - Auditoria Externa

Este produto financiará a contratação de auditoria externa independente para verificar a execução financeira e a conformidade do Programa, com emissão de relatórios anuais ao longo da implementação, em conformidade com o Contrato de Empréstimo e os requisitos do BID.

A auditoria contemplará, no mínimo.

1. Revisão das demonstrações financeiras do Programa, conciliações, desembolsos e comprovações.

2. Verificação de aderência a normas e procedimentos aplicáveis, incluindo controles internos e rastreabilidade de gastos.

3. Avaliação de aspectos operacionais e administrativos relevantes para a boa governança do Programa.

4. Emissão de relatórios anuais com conclusões, recomendações e plano de ação para eventuais ajustes, reforçando transparência e accountability.

Valor estimado: US$ 100.000,00.

1. 6. **Beneficiários**

O público-alvo prioritário do projeto reflete o compromisso com a equidade, o fortalecimento do SUS e a redução das desigualdades em saúde. As ações estruturais e institucionais visam suavizar carências assistenciais, socioeconômicas e territoriais, ampliando o acesso, a qualidade do cuidado e a sustentabilidade do sistema municipal de saúde de João Pessoa.

Os grupos beneficiários e suas características são os seguintes:

- Idosos (? 60 anos) = ~14% da população (?120 mil pessoas)

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Necessidade de atenção multiprofissional, reabilitação e cuidado contínuo.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da Policlínica do Idoso com a ampliação de oferta de serviços geriátricos.

- Pessoas com Doenças Crônicas e Condições Oncológicas = Estimados 35 mil pacientes ativos na rede municipal.

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Falta de leitos e serviços oncológicos próprios; dependência de prestadores externos.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção do Hospital Oncológico e fortalecimento do HMSI.

- Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiências Intelectuais = ~5.000 pessoas (crianças e adultos)

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Falta de diagnóstico precoce, terapias multiprofissionais e apoio às famílias.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da Unidade de Referência TEA

- Usuários do SUS com demandas de urgência e emergência = Média de 450 mil atendimentos/ano

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Necessidade de tempo-resposta adequado e estrutura física moderna.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da Base do SAMU e ampliação da rede hospitalar.

- Servidores do município de João Pessoa

-Carências e Necessidades a Serem Endereçadas = Necessidade de capacitação contínua e modernização da gestão.

-Relação com os Objetivos Específicos e Metas = Construção da nova Sede da SMS-JP e programas de Educação Permanente.

1. 12. **Anexos**

PLANO DE GOVERNO - João Pessoa no caminho Certo 2024

Encaminhamento do Projeto REDS+JP para Reapreciação pela Cofiex

ANEXO - COMPLEMENTO DOS COMPONENTES 01 E 02

Apresentação do REDS+JP

Resposta a Solicitação de Revisão.

2. **ÁREAS ESTRATÉGICAS**

2. 1. **Áreas estratégicas**

O REDS+JP está integralmente alinhado às prioridades do Plano Plurianual (PPA 2024–2027), com destaque para a Área Estratégica IV – Saúde: atenção primária e especializada, conforme o §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024.

Em atendimento às recomendações constantes na Nota Técnica SEI nº 332/2026/MPO, o Projeto foi reestruturado de modo a incorporar, de forma explícita, mensurável e orientada a resultados, elementos relacionados ao aprimoramento da capacidade assistencial, à eficiência operacional e ao fortalecimento da governança do sistema municipal de saúde.

Apresenta-se, a seguir, a análise de aderência às diretrizes estratégicas do PPA, evidenciando a correspondência entre os problemas identificados, as recomendações técnicas e as soluções propostas no âmbito do Projeto.

Objetivos Estratégicos do PPA relacionados ao Programa

OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do SUS

O objetivo geral está diretamente alinhado ao OE 102, ao propor a transformação da rede municipal de saúde, com ampliação da capacidade assistencial, melhoria da qualidade do cuidado e fortalecimento da gestão, em conformidade com as diretrizes do SUS.

Os Objetivos Específicos A, B e C incorporam essas diretrizes, com destaque para:

- Expansão da oferta de serviços de média e alta complexidade
- Reorganização dos fluxos assistenciais
- Redução da dependência de serviços contratados

Foram definidos indicadores no padrão SMART diretamente associados aos principais gargalos identificados:

- Redução do tempo de espera para consultas especializadas
- Redução do tempo de espera para cirurgias eletivas
- Redução do tempo de regulação de leitos
- Ampliação da produção própria assistencial

O Componente 1 concentra os investimentos assistenciais e operacionaliza a resposta aos problemas de acesso, promovendo maior resolutividade da rede.

Embora o Projeto REDS+JP concentre seus investimentos na ampliação da atenção especializada (média e alta complexidade), destaca-se que sua concepção está fundamentada na lógica de organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), garantindo a integração com a Atenção Primária à Saúde (APS).

Nesse contexto, os investimentos previstos produzem efeitos estruturantes sobre a APS, ao:

- Reduzir a pressão assistencial sobre a atenção primária, por meio da ampliação do acesso à atenção especializada;
- Melhorar a resolutividade do cuidado, com retaguarda assistencial qualificada;
- Organizar fluxos regulados entre os níveis de atenção, fortalecendo a coordenação do cuidado;
- Ampliar o acesso a serviços estratégicos para populações acompanhadas na APS.

Adicionalmente, o Projeto incorpora elementos de fortalecimento indireto da APS, por meio de:

- Integração dos sistemas de regulação e informação em saúde;
- Estruturação de protocolos assistenciais e linhas de cuidado;
- Qualificação da gestão do acesso e da continuidade do cuidado.

Dessa forma, ainda que os recursos estejam majoritariamente direcionados à atenção especializada, o modelo proposto promove o fortalecimento sistêmico da rede de saúde, com impactos diretos sobre a eficiência, a resolutividade e a coordenação da Atenção Primária à Saúde, em plena consonância com a Prioridade IV do Plano Plurianual 2024–2027.

Afirma-se que o desenho do Projeto adota abordagem de rede, na qual a expansão da atenção especializada atua como elemento estruturante para o fortalecimento da APS, e não como componente isolado.

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

O Projeto incorpora a diretriz de integração entre saúde e território, posicionando os equipamentos de saúde como elementos estruturantes da rede de equipamentos sociais.

Destacam-se:

- Expansão da infraestrutura em áreas com vazios assistenciais
- Integração dos serviços de saúde à rede urbana
- Melhoria da acessibilidade e da eficiência na utilização dos serviços públicos

Os investimentos em infraestrutura passam a estar associados à organização territorial do acesso e à racionalização do uso da rede.

OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O REDS+JP adota abordagem explícita de impacto regional, reconhecendo o município de João Pessoa como referência da 1ª Macrorregião de Saúde da Paraíba.

Nesse sentido, contempla:

- Análise de fluxos assistenciais intermunicipais
- Identificação de déficits regionais de oferta
- Expansão de serviços estratégicos de média e alta complexidade

Os investimentos previstos, especialmente na área oncológica e em unidades especializadas, contribuem para a ampliação da cobertura regional e a redução do deslocamento de pacientes.

Adicionalmente, são incorporados indicadores de impacto regional, tais como:

- Redução do deslocamento de pacientes
- Ampliação da cobertura de serviços especializados

A proposta fundamenta-se na existência de vazios assistenciais e concentração de serviços especializados na capital, evidenciada pela elevada demanda regulada proveniente de municípios da macrorregião, indicando desigualdade no acesso à média e alta complexidade.

OE 302 – Promover o aperfeiçoamento das capacidades estatais

O Projeto incorpora essa diretriz por meio do Objetivo Específico C, contemplando:

- Estruturação de modelo de gestão orientado a resultados
- Implantação de painéis de indicadores
- Monitoramento contínuo do desempenho assistencial e operacional

O Componente 2 passa a incluir explicitamente:

- Modernização da governança
- Estruturação da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP)
- Implantação de sistemas de monitoramento e avaliação

Adota a abordagem estruturada de fortalecimento das capacidades estatais, com implantação de modelo de gestão por resultados, integração entre planejamento, regulação e assistência, e institucionalização de rotinas de monitoramento e avaliação.

OE 303 – Intensificar a transformação digital no governo

Apresenta a transformação digital como eixo transversal, incluindo:

- Implantação de sistema de regulação digital integrado
- Desenvolvimento de painéis de gestão em tempo real

Adicionalmente, são incluídos indicadores específicos, tais como:

- Tempo de resposta regulatória

Os indicadores do projeto refletem diretamente os ganhos esperados com a digitalização, especialmente nos tempos de acesso e regulação.

A transformação digital proposta não se limita à infraestrutura tecnológica, mas compreende a digitalização dos processos assistenciais e regulatórios, com impacto direto na gestão do acesso, na tomada de decisão e na eficiência do sistema de saúde.

OE 306 – Assegurar sustentabilidade fiscal e eficiência administrativa

Evidencia sua contribuição para a sustentabilidade fiscal por meio de:

- Ampliação da produção própria da rede municipal
- Redução progressiva da contratualização externa
- Otimização de processos assistenciais e administrativos

Foram incorporados indicadores de eficiência, tais como:

- Percentual de produção própria em Média e Alta Complexidade (MAC)
- Percentual de execução orçamentária da saúde

O modelo proposto contribui para maior previsibilidade, controle e racionalidade do gasto público em saúde.

O Projeto contempla abordagem explícita de eficiência do gasto público, com foco na redução da dependência de prestadores externos, ampliação da produção própria e melhoria da previsibilidade orçamentária, contribuindo diretamente para a sustentabilidade fiscal do sistema municipal de saúde.

OE 106 – Promover os direitos humanos e a inclusão social

Adota abordagem transversal estruturada de direitos humanos, com foco na equidade no acesso à saúde.

São contempladas linhas de cuidado específicas para grupos prioritários:

- Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Idosos
- Pacientes oncológicos
- Mulheres e crianças

Inclui-se a implantação de protocolos assistenciais orientados por:

- Equidade
- Acesso oportuno
- Integralidade do cuidado

Adicionalmente, são previstos indicadores de monitoramento da equidade, incluindo:

- Tempo de acesso por grupo prioritário
- Cobertura assistencial segmentada

A expansão da rede e a implantação de unidades especializadas reforçam a garantia do direito à saúde como direito fundamental.

O monitoramento da equidade será operacionalizado por meio da desagregação dos indicadores de acesso por grupos prioritários, permitindo avaliação específica do tempo de espera e do acesso aos serviços especializados para populações vulneráveis.

O Projeto apresenta um modelo orientado a resultados, com indicadores no padrão SMART, metas progressivas e mecanismos de monitoramento e avaliação, incorporando, ainda, elementos essenciais como a qualificação da regulação assistencial, a transformação digital, o fortalecimento da capacidade instalada da rede própria e a melhoria da eficiência do gasto público.

Como também apresenta critérios técnicos de relevância, consistência e aderência às políticas públicas federais, estando apto a contribuir de forma efetiva para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, regional e estadual, considerando que é unidade executora dos 222 municipios e a população própria.

2. 47. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do projeto REDS+JP contará com a participação de diversas instituições municipais e parceiras, que atuarão de forma integrada para garantir a execução eficiente, a transparência e a sustentabilidade das ações planejadas.

1. Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Papel: Órgão executor e responsável pela governança geral do projeto.
Atribuições:

- Planejar, coordenar e supervisionar todas as etapas do projeto; Promover a integração das ações entre os setores administrativos, financeiros e operacionais; Assegurar o alinhamento às diretrizes do Plano Municipal de Saúde e do Plano Anual de Saúde - PAS vigente.

2. Chefia de Gabinete da SMS

Papel: Instância de assessoramento estratégico e articulação política.
Atribuições:

- Apoiar tecnicamente o Secretário Municipal de Saúde; Promover o alinhamento intersetorial e a comunicação institucional; Monitorar a execução das metas e apoiar a tomada de decisão.

3. Procuradoria Geral do Município - Procuradoria Setorial _ PROSET

Papel: Órgão de controle interno do projeto.
Atribuições:

- Fiscalizar a execução física e financeira; Analisar conformidade documental e orçamentária; Supervisão da integridade, conformidade e transparência

4. Diretoria Administrativa-Financeira

Papel: Unidade responsável pela gestão administrativa e financeira.
Atribuições:

- Coordenar as áreas de Gestão de Pessoas, Administração e Finanças; Coordenar as áreas de engenharia

5. Diretoria de Contratação Pública

Papel: Unidade responsável pela gestão de contratação

Atribuições:

- Coordenar as áreas de Licitações e Aquisições

6. Diretoria de Planejamento e Gestão

Papel: Núcleo de planejamento, monitoramento e avaliação.
Atribuições:

- Estruturar o sistema de monitoramento e indicadores do projeto; Elaborar relatórios de desempenho e relatórios de gestão; Conduzir processos de avaliação.

7. Unidade de Gerenciamento do Programa

Papel: Responsável pela execução técnica das ações em campo.
Atribuições:

- Coordenar os Componentes do programa; Monitorar cronogramas, metas e resultados operacionais; Relatar avanços e desafios à Diretoria de Planejamento e à Chefia de Gabinete.

3. 1. 9. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Saúde (SMS JP)
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas – SESOP
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Procuradoria Geral do Município

3. 1. 10. **Estrutura Operacional:**

A execução do projeto REDS+JP será conduzida por instituições que possuem comprovada capacidade técnica e administrativa, assegurando a implementação eficaz e coordenada das ações planejadas.

A SMS JP, como órgão executor do programa, possui experiência consolidada na gestão de projetos voltados para a melhoria da infraestrutura e serviços de saúde pública. A Equipe técnica qualificada composta por profissionais de áreas estratégicas para execução do Programa, tais como:

Unidade / Diretoria	Principais Atribuições	Composição da Equipe	Quantidade de pessoas
Gabinete do Secretário	Coordenação geral do projeto, articulação interinstitucional, comunicação estratégica e tomada de decisão.	Secretário Municipal, Secretária Executiva e Assessores	4

Diretoria de Planejamento e Gestão	Alinhamento do projeto ao Plano Municipal de Saúde e PPA; análise de metas e priorização de investimentos. Formulação, monitoramento e avaliação do plano de trabalho; gestão de indicadores e metas.	Gestor de Políticas Públicas e Administrador.	2
Diretoria de Contratação Pública	Condução de processos licitatórios	Pregoeiro, Analista de Compras, Advogado e Técnico Administrativos.	4
Diretoria de Finanças e Administração	Execução orçamentária e financeira do projeto, controle contábil e prestação de contas, engenharia, almoxarifado, manutenção.	Contadores, Engenheiros, Controladores Internos, técnicos administrativos.	6
Diretoria da Atenção Básica	Coordenação das unidades de atenção primária, contendo as sedes de Distrito Sanitários.	Diretora A.B. e gerentes dos Distritos Sanitários.	2

Diretoria da Atenção Especializada	Gestão dos serviços especializados	Diretora da especializada e gerentes das policlínicas	2
Diretoria da Atenção Hospitalar	Gestão dos serviços hospitalares de média e alta complexidade	Diretor Hospitalar e Gestores Hospitalares	2
PROSET – Coordenação de Controle e Fiscalização	Controle interno, auditoria, verificação de conformidade e acompanhamento de execução física e financeira.	Procurador e Técnico responsável	2

A SMS-JP dispõe de uma estrutura robusta, com equipe técnica multidisciplinar e sistemas de apoio à gestão, assegurando a governança, a rastreabilidade e o controle dos recursos aplicados.

Não haverá repasse direto de recursos entre os órgãos parceiros. Toda a execução orçamentária será centralizada na SMS-JP, sob controle contábil da Secretaria de Finanças (SEFIN) e fiscalização da PROSET, garantindo integridade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

O Município de João Pessoa possui experiência concreta e reconhecida na execução de projetos financiados por organismos internacionais — demonstrando não apenas capacidade de captar recursos, mas também competência técnica e administrativa para realizar projetos de larga escala com impacto social e urbano significativo.

Entre as parcerias de destaque, estão aquelas firmadas com o Ministério da Saúde e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a exemplo do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável de João Pessoa/PB (Financiamento BID), voltado à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população. Essas iniciativas evidenciam a competência do município em alinhar-se às diretrizes nacionais e internacionais de governança, planejamento e avaliação de políticas públicas, e do Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (2020).

Essa trajetória reflete a busca contínua do município por parcerias sustentáveis e inovadoras, orientadas por evidências e comprometidas com a efetividade das ações públicas, fortalecendo sua inserção em redes de cooperação internacional e contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

3. 1. 11. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE REDS+JP.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A implementação do REDS+JP – Reorganização e Expansão a Garantir o Direito à Saúde em João Pessoa prevê a adoção de estratégias robustas para assegurar a continuidade das ações e a sustentabilidade operacional, técnica e financeira após o encerramento do apoio de financiamento externo.

O projeto adota uma abordagem de sustentabilidade integrada, abrangendo todas as fases — concepção, execução, monitoramento e pós-implantação —, assegurando que os investimentos, infraestruturas, equipamentos e serviços implementados mantenham-se plenamente operacionais ao longo do tempo. Com as seguintes estratégias de sustentabilidade operacional, técnica e financeira:

- Incorporação ao Planejamento Municipal: todas as ações e estruturas criadas pelo REDS+JP serão integradas ao Plano Municipal de Saúde (PMS) e à Programação Anual de Saúde (PAS) subsequente, garantindo respaldo orçamentário e institucional permanente.

- Capacitação contínua das equipes: as equipes técnicas e assistenciais envolvidas serão capacitadas em gestão, manutenção de equipamentos, protocolos assistenciais e boas práticas operacionais.

- Manutenção preventiva e corretiva: será instituído um plano de manutenção preventiva e corretiva de obras e equipamentos, coordenado pela Diretoria Administrativa-Financeira, conforme padrões do Ministério da Saúde e da Anvisa.

- Adoção de sistemas de informação integrados: utilização dos sistemas e-SUS, SIA/SIH-SUS e outros que estejam em prática conforme orientações do Ministério da Saúde, que permitirão o acompanhamento contínuo de indicadores e metas de desempenho.

- Monitoramento e avaliação pós-implantação: as ações serão acompanhadas por meio de relatórios semestrais de desempenho, com indicadores de resultado e de sustentabilidade definidos no momento da pactuação.

- Inclusão dos custos de manutenção no orçamento municipal da saúde, garantindo dotação anual específica para custeio de equipamentos, serviços de limpeza, segurança e energia elétrica das novas unidades.

- Aproveitamento das fontes regulares do SUS, como Blocos de Custeio da Atenção Primária e da Média e Alta Complexidade, além de eventuais incentivos do Ministério da Saúde para continuidade da assistência.

- Contratualização de metas assistenciais e orçamentárias com as unidades executoras, promovendo eficiência e controle sobre os gastos.

- Gestão de riscos fiscais, conforme orientações do Manual de Gestão de Riscos, assegurando reservas financeiras e mitigação de eventuais descontinuidades orçamentárias.

A sustentabilidade financeira foi estimada com base na média de custos de manutenção da rede municipal de saúde e nas planilhas referenciais do DATASUS e da Caixa Econômica Federal (PAC Saúde):

Categoria	Descrição	Custo Anual Estimado (U$)	Fonte de Financiamento
Manutenção Predial	Serviços de conservação, limpeza e pequenos reparos nas unidades beneficiadas	140.000,00	Tesouro Municipal / Recursos Próprios
Manutenção de Equipamentos	Calibração, peças de reposição e contratos de manutenção preventiva	78.000,00	Tesouro Municipal / Recursos Próprios
Despesas de Operação	Energia, água, vigilância e serviços gerais	177.000,00	Tesouro Municipal / Recursos Próprios
Total Estimado Anual		395.000,00	

A implantação do REDS+JP representa uma mudança estrutural no modelo de financiamento e gestão dos serviços de saúde no município. Os recursos atualmente destinados à assistência contratualizada passarão a ser investidos diretamente na rede própria, fortalecendo a gestão municipal. Isso garante que os valores sejam aplicados exclusivamente conforme a Tabela SUS, sem complementos ou adicionais contratuais, promovendo maior racionalidade, transparência e sustentabilidade financeira. Estando esse estabelecimento habilitado pelo SUS, com as possíveis vinculações de portarias de custeio.

3. 12. **Planejamento Estratégico**

O Projeto RED+JP está plenamente alinhado ao planejamento municipal de saúde vigente e contribui diretamente para o cumprimento das metas e entregas previstas no Plano Municipal de Saúde - PMS 2022-2025 vigente (Anexo).

A integração estrutural das ações do projeto à rotina da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com incorporação das atividades e metas aos instrumentos de planejamento municipal — PPA, PMS, PAS (2025) — assegurando a

perenidade institucional.

O Programa está alinhado ao PPA JP (2026-2029) (Anexo) nos seguintes programas:

- Programa 5005 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - páginas 12 a 15 do arquivo anexo.
- Programa 5139 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE IMÓV - página 24 do arquivo anexo.

O RED+JP também endereça compromissos assumidos no Plano de Governo 2026, nas páginas 13 -14.

3. 15. **Anexos**

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2022 - 2025

PLANO DE GOVERNO - João Pessoa no Caminho Certo 2024

ORGANOGRAMA ARRANJO INSTITUCIONAL REDES+JP

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2025

ESPELHO DO PPA JP PARA O REDS+JP

PPA JP 2026-2029

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Atraso na tramitação e aprovação de licenças e autorizações institucionais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Quando há demora na obtenção de aprovações junto a órgãos municipais, estaduais ou federais (como licenças ambientais, autorizações sanitárias e pareceres técnicos), impactando o cronograma de execução do projeto e a liberação de recursos do financiamento internacional. As causas podem incluir entraves burocráticos, ausência de equipes técnicas dedicadas ou sobreposição de competências entre órgãos.

Prevenção e Mitigação:

- Acompanhamento da Comissão Intersetorial da SMS
- Planejamento antecipado das demandas junto aos órgãos licenciadores.
- Monitoramento periódico das pendências via painel de controle do projeto.
  Responsável: Unidade Executora do Projeto / Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

4. 5. **Informações do 2° risco:**
Nome: Elevação dos custos de obras e equipamentos durante a execução.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Em razão de variações inflacionárias, reequilíbrios contratuais e atrasos na execução que resultam em custos adicionais não previstos. Pode comprometer a execução financeira e exigir reprogramação orçamentária.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de critérios de reajuste contratual claros conforme legislação.
Acompanhamento de mercado.

Responsável: Unidade de Gestão do Projeto (UGP)/ Comissão Intersetorial da SMS

4. 6. **Informações do 3° risco:**
Nome: Insuficiência de pessoal técnico qualificado para operação das novas estruturas e sistemas.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A ampliação da rede física e tecnológica poderá demandar profissionais especializados em áreas como engenharia clínica, TI e gestão hospitalar. A falta de capacitação pode gerar baixa utilização dos equipamentos e dificuldades operacionais.

Prevenção e Mitigação:
Execução de plano de capacitação continuada para gestores e equipes técnicas.
Criação de cargos estratégicos via reestruturação organizacional da SMS.
Responsável: SMS

4. 7. **Informações do 4° risco:**
Nome: Atrasos ou falhas em licitações e contratos.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Processos licitatórios complexos, especialmente para obras e equipamentos hospitalares, podem enfrentar impugnações, recursos ou anulações, gerando atrasos significativos na execução do cronograma.

Prevenção e Mitigação:
Padronização de termos de referência e editais tipo BID.
Assessoramento técnico da Procuradoria Geral do Município e controle interno.

Responsável: UGP/Comissão Intersetorial da SMS

4. 8. **Informações do 5° risco:**
Nome: Atrasos na elaboração e aprovação dos projetos de arquitetura e engenharia
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atrasos na entrega, revisão ou aprovação dos projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia, comprometendo o cronograma das obras previstas. As causas incluem falta de alinhamento entre projetistas, falhas de compatibilização técnica, exigências complementares dos órgãos de licenciamento e morosidade nas análises internas.

Prevenção e Mitigação:
- Contratação de equipe técnica de acompanhamento exclusivo (engenharia e fiscalização).
- Realização de revisões técnicas intermediárias com checklist padrão TCU/ABNT.
- Cronograma integrado de validação junto à Vigilância Sanitária, SEMAM e Corpo de Bombeiros.

Responsável: UGP / Secretaria Municipal de Infraestrutura / SMS.

4. 12. **Informações do 6° risco:**
Nome: Dificuldades na aquisição de equipamentos médico-hospitalares
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de desabastecimento ou atrasos na entrega de equipamentos, devido à escassez de fornecedores, problemas logísticos ou restrições cambiais. Pode comprometer a operacionalização do Hospital Oncológico e demais unidades.

Prevenção e Mitigação:
- Planejamento antecipado das licitações com fase preparatória robusta (TCU, 2020).
- Contratos com cláusulas de performance e garantias contratuais de entrega.
  Responsável: UGP / Setor de Compras / SMS.

4. 15. **Informações do 7° risco:**
Nome: Restrições e atrasos na execução de obras em prédio tombado
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Ocorre quando as intervenções em edifício ou terreno sob proteção do patrimônio histórico, artístico ou cultural enfrentam restrições técnicas e legais impostas por órgãos de preservação, o que pode afetar o cronograma, elevar custos e exigir alterações de projeto. As exigências de conservação, métodos construtivos específicos e necessidade de acompanhamento arqueológico podem gerar atrasos, aumento de custos e necessidade de readequação contratual.

Prevenção e Mitigação:

- Aprovação prévia e acompanhamento contínuo

- Planejamento de contingência financeira e temporal para eventuais revisões de projeto

Responsável: UGP / Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria de Infraestrutura

4. 18. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	99.200.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	24.800.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
SOFR + margem de fundo em relação a SOFR (0,41% para o 1º trimestre 2025) + acrescida de spread de crédito (0,80% para o ano de 2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
0,5% semestral do valor do saldo do desembolso
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Aprimoramento de Serviços de Saúde Pública					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
14.176.000,00	2.740.618,00	33.473.788,00	3.933.084,00	24.087.500,00	2.236.414,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.500.000,00	2.916.212,00	3.365.000,00	0,00		

Nome do componente					
Fortalecimento Institucional					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.000.000,00	2.706.700,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
8.600.000,00	4.828.736,00	4.060.712,00	3.938.236,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
250.000,00	0,00	725.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
905.000,00	0,00	632.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

1. receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;
2. recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e
3. recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

AVALIAÇÃO DO TERRENO _ PRODUTO P1.3_HC

AVALIAÇÃO DO TERRENO _ PRODUTO 2.2 _SEDE

AVALIAÇÃO DO TERRENO _ PRODUTO P1.4_TEA

AVALIAÇÃO DO TERRENO _ PRODUTO P1.7_SEDESAMU

AVALIAÇÃO DO TERRENO _ PRODUTO 1.8_IDOSO

AVALIAÇÃO DO TERRENO _ PRODUTO SEDE DS I

AVALIAÇÃO DO TERRENO_PRODUTO SEDE DS II

AVALIAÇÃO DO TERRENO _ SEDE DS IV

AVALIAÇÃO DO TERRENO_ SEDE DS V

AVALIAÇÃO DO TERRENO_SEDE DS VI

Cronograma dos Produtos

MATRIZ COMPONENTES E PRODUTOS POR ANO

Carta de anuência

AVALIAÇÃO DO TERRENO_SEDE DS III

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como estágio prévio das ações do referido Projeto, o município de João Pessoa vem aplicando ações que contemplam a escala de prioridade para o aprimoramento de Serviços de Saúde Pública e fortalecimento institucional.

O município de João Pessoa vem oferecendo ampliação na rede de atenção primária, com CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, de forma a garantir boas condições na assistência à saúde. Assim como a construção do CER IV garantindo assistência para a linha de cuidado com deficiência. Sendo implantado um novo serviço de assistência a garantir a retaguarda e ampliar a oferta, HOSPITAL DIA IRMÃ BEATRIZ FRAGOSO.

Em 2025, o município de João Pessoa foi contemplado com recurso ministerial (PAC) para a construção de uma Maternidade, com previsão de início no primeiro semestre de 2026, já possuindo o terreno, e com projeto arquitetônico pronto. Garantindo assim, melhor assistência, com ampliação de leitos e serviços para atendimento da rede materno infantil, no cuidado ampliado para redução de morte materna, além de ser aquisição de um serviço de gestão própria. Essa construção vem no momento de grande importância, considerando que a morte materna em 2025, João Pessoa registrou 15 mortes maternas (sendo apenas 03 residentes), o que representa mais da metade dos casos do estado.

No ano de 2025, a SMS vem aplicando a nova Lei Ordinária contemplando a nova estrutura administrativa e organizacional. A atualização do ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de João Pessoa (SMS/JP) representa uma iniciativa fundamental para o fortalecimento da gestão pública em saúde, diante de um cenário institucional que há quase duas décadas necessitava de adequações formais compatíveis com as transformações vivenciadas no Sistema Único de Saúde (SUS), nas legislações nacionais e nas exigências dos órgãos de controle. Reafirmando o compromisso da SMS/JP com a melhoria contínua da atenção à saúde e com a construção de políticas públicas sustentadas na legalidade, na equidade e na eficiência, pensa-se no colaborador bem estruturado e com condições físicas, tecnológicas e possível de aplicar o melhor atendimento ao cidadão.

Essas ações demonstram o compromisso do Município de João Pessoa/PB com o fortalecimento da rede de saúde, e evidenciam que o REDS+JP está alicerçado em etapas prévias concretas e articuladas com políticas públicas nacional, estadual e municipal conferindo maior viabilidade e sustentabilidade à sua execução.

6. 2. Anexos

Sem anexos.